

Ukryta *kompulsja*

„Czy na pewno wyłączyłem?”. To pytanie wygląda jak rozmowa — ale jest kompulsją werbalną, jak mycie rąk.

CZAS: ciągła praktyka Z udziałem bliskich

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1999); Rachman (2002); Kobori i Salkovskis (2013)

JAK UŻYWAĆ

Zidentyfikuj **wszystkie formy** szukania zapewnienia: pytania bliskim, googlowanie objawów, sprawdzanie wiadomości, wyznawanie „grzechów”, prośby o potwierdzenie u terapeuty. **Nazwij to kompulsją** — nie „normalnym pytaniem”. Ustal *umowę z bliskimi*: „Wiem, że to OCD. Wierzę, że dasz radę”. Stopniowo redukuj: opóźnienie → 1×/dzień → eliminacja.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Szukanie zapewnienia (ang. *reassurance seeking*) to „**ukryta**” **kompulsja** — pytanie traktowane przez pacjenta i otoczenie jak *normalna rozmowa*, nie kompulsja. Kobori i Salkovskis (2013): **unikalny predyktor** nasilenia OCD — silniejszy niż większość innych kompulsji widocznych. Każde zapewnienie daje *krótką ulgę* (jak mycie rąk) i **wzmacnia cykl OCD**. Im więcej zapewnienia dostajesz, tym *więcej go potrzebujesz* — mechanizm jak tolerancja w uzależnieniu. Wymaga **współpracy z otoczeniem** — bliscy „pomagają” odpowiadając, co utrwala cykl. Bez świadomej umowy redukcja jest niemożliwa.

01 ? Formy szukania zapewnienia — często niezauważane

PYTANIA BLISKIM

„Czy zamknąłem drzwi?”, „Czy jestem dobrą osobą?”, „Czy ta myśl jest normalna?”. **Najczęstsza forma**. Bliscy odpowiadają „na pewno tak” — i wzmacniają cykl.

GOOGLOWANIE OBJAWÓW

„Czy ta myśl oznacza, że jestem...”. Sprawdzanie internetu, forów, artykułów medycznych. Czasem godziny dziennie. **To kompulsja**, nie ciekawość.

WYZNAWANIE „GRZECHÓW”

„Pomyślałem coś okropnego, muszę Ci to powiedzieć”. Spowiedź, terapeutcie, partnerowi. **Cel**: usłyszeć „to nic strasznego”. To zapewnienie.

SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI

„Czy nie napisałem czegoś niewłaściwego?”. Powtarzane odczytywanie e-maili, wiadomości, wpisów. Szukanie potwierdzenia, że *nic nie zrobiłem źle*.

WEWNĘTRZNE ZAPEWNIANIE

W głowie: „na pewno jest OK...”, „nic złego się nie stanie...”. **Najtrudniejsza do wykrycia** — pacjent sobie sam daje zapewnienie. Patrz: karta kompulsje mentalne.

02 ☉ Mechanizm tolerancji — jak w uzależnieniu

CYKL WZMACNIAJĄCY

Tydzień 1: jedno zapewnienie wystarcza. Ulgą 30 min.

Miesiąc 3: 3 zapewnienia. Ulgą 10 min.

Rok 1: 10 zapewnień. Ulgą 2 min.

Każda dawka mniej skuteczna. Tolerancja jak w uzależnieniu.

REDUKCJA STOPNIOWA

Krok 1: opóźnienie 30 min. Często impuls mija.

Krok 2: 1× dziennie, nie więcej.

Krok 3: eliminacja. Toleruj impuls bez zaspokajania.

Pierwsze dni najtrudniejsze. Tydzień 2 — wyraźna ulga.

03 Umowa z bliskimi — Twoja

Bliscy muszą wiedzieć, że ich „pomoc” w odpowiadaniu utrwała OCD. Przygotuj **krótki list / rozmowę**.

LISTA OSÓB, KTÓRE „POMAGAJĄ” ODPOWIADAJĄC

— partner, rodzic, przyjaciel

NAJCZĘSTSZE PYTANIA, KTÓRE IM ZADAJĘ

— konkretnie

FORMUŁA DLA BLISKICH — PROPONOWANA ODPOWIEDŹ

„Kocham Cię i wiem, że to OCD. Zgodnie z naszą umową nie odpowiem na to pytanie — to byłoby zapewnienie, które utrwała Twoje OCD. Wierzę, że dasz radę poczekać, aż impuls minie. Możemy zająć się czymś razem?”

04 Traktuj impuls jak ekspozycję

1 • ZAUWAŻ

„Chcę zapytać X o...”. **Nazwij to:**
„to impuls do szukania
zapewnienia, to kompulsja”.

2 • TOLERUJ

Nie pytaj. **Zauważ dyskomfort:**
gdzie czuję? Skala SUDS. Czekaj
— 15 min, 30 min. Impuls *mija*
sam.

3 • OBSERWUJ WYNIK

„Nie zapytałem/-am — i nic się nie
stało”. Mózg *uczy się*: zapewnienie
nie było potrzebne.

Pułapka: „pytanie tylko raz”. Każde „*tylko raz*” to mała dawka — utrzymuje cykl. Lepsza strategia: **czekaj 30 min**. Jeśli po 30 min nadal chcesz pytać — czekaj kolejne 30 min. Impuls zwykle mija w 60 min.

Klucz: Kobori i Salkovskis (2013): redukcja szukania zapewnienia jest **silniej skorelowana** z poprawą OCD niż większość innych zmian behawioralnych. Mechanizm jest *identyczny* jak w innych kompulsjach — krótka ulga, długoterminowe wzmocnienie. Bez współpracy bliskich praca jest jak *walka z ogniem* przy ciągłym dolewaniu oleju. Bliscy mówiący „*nie*” z miłością — to **krytyczny element** terapii. Łącz z pracą nad *tolerancją niepewności* i *akomodacją rodzinną*.